

CEFATOP 300

Antibiótico Cefalosporínico de Primera Generación con Módulo de Citoprotección Hepática y Estabilización de Membranal.

COMPOSICIÓN: Cada tableta contiene: Cefalexina 300 mg, Silimarina 80 mg. Excipientes c.s.p.1 tableta

INDICACIONES CLÍNICAS Y ESPECTRO CEFATOP 300 Esta indicado para el tratamiento de infecciones de la piel y tejidos blandos. Infecciones genito-uritarias. Infecciones respiratorias (neumonía, faringitis), infecciones del oído (otitis media), Infecciones oseas y articulares. Contra patógenos Gram-positivos y Gram-negativos seleccionados: Staphylococcus pseudintermedius, Pasteurella multocida, Staphylococcus aureus, S. intermedius, S. epidermidis, (Piodermas). Streptococcus spp. Escherichia coli, Klebsiella y Proteus mirabilis.

ESPECIES: Perros y Gatos

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

DOSIFICACIÓN RECOMENDADA Basado en modelos farmacocinéticos estándar: Caninos: 22-30 mg/kg de peso vivo cada 12 horas. (1 tableta para 20Kg de peso vivo) Felinos: 15-20 mg/kg de peso vivo cada 12-24 horas. (1/2 tableta para 7 kg. de peso vivo) Cada 12 horas por 7 días o según criterio Médico

DESCRIPCIÓN MOLECULAR Y COMPOSICIÓN Cada unidad de dosificación integra un sistema de co-administración diseñado para mitigar el impacto metabólico de la terapia antibiótica prolongada: Cefalexina Monohidrato (300 mg): Ácido (6R,7R)-7-((R)-2-amino-2-phenylacetamido)-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo(4.2.0)oct-2-ene-2-carboxylic. Y Complejo de Silimarina (80 mg): Fracción purificada de flavonolignanos (Silibina A+B, Isosilibina A+B, Silidianina y Silicristina) extraída de Silybum marianum.

FUNDAMENTOS DE FARMACODINAMIA MOLECULAR

Dinámica Antimicrobiana: La cefalexina ejerce un efecto bactericida tiempo-dependiente. Su mecanismo se basa en el acoplamiento irreversible a las Proteínas Fijadoras de Penicilina (PBP 1A, 1B, 2 y 3) situadas en la cara interna de la membrana citoplasmática bacteriana. Bloqueo de Transpeptidación: Inhibe la formación de puentes cruzados de peptidoglicano, comprometiendo la integridad estructural de la pared celular. Lisis Automática: La interrupción de la síntesis activa las autolisinas bacterianas, resultando en la degradación osmótica del microorganismo.

Mecanismo de Citoprotección Hepática (Silimarina) La silimarina no actúa como un agente antimicrobiano, sino como un modulador metabólico del hospedador. Sustrato de Regeneración: Estimula la actividad de la ARN polimerasa I en el nucléolo del hepatocito, incrementando la síntesis de proteínas ribosomales y la capacidad de reparación del parénquima hepático. Barrera Antioxidante: Actúa como un captador de radicales libres (scavenger) y aumenta la concentración intracelular de Glutatión, previniendo la peroxidación lipídica inducida por la biotransformación de xenobióticos.

PERFIL FARMACOCINÉTICO (PK) Absorción: Biodisponibilidad superior al 90% tras administración oral. El tiempo máximo de concentración se alcanza entre 1.5 a 2 horas en cánidos. Distribución: Presenta una baja unión a proteínas plasmáticas (~20%), permitiendo una difusión eficiente hacia el fluido intersticial, tejido óseo y líquido sinovial. Eliminación: La cefalexina se excreta de forma inalterada mediante filtración glomerular y secreción tubular activa (80% en las primeras 8 horas).

La silibina (componente mayoritario de la silimarina) presenta una absorción limitada por su baja solubilidad lipídica. No obstante, la formulación en matriz polimérica mejora su dispersión molecular, permitiendo una absorción plasmática cuantificable en 2-4 horas. Distribución y Unión a Proteínas

Farmacocinética Comparada de Alta Densidad (Perros vs. Gatos) La respuesta biológica difiere críticamente entre ambas especies debido a sus perfiles metabólicos individuales:

Parámetro Farmacocinético	Caninos (Perros)	Felinos (Gatos)	Significado Clínico Doctoral
Absorción (Cefalexina)	Rápida y casi total (F > 85%).	Excelente, pero con Tmax ligeramente retrasado.	La presencia de alimento reduce la velocidad, pero no la cantidad total absorbida (AUC).
Vida Media (t1/2)	≈ 1.5 – 2.0 horas.	≈ 2.5 – 3.2 horas.	El aclaramiento es más lento en gatos; las dosis repetidas acumulan niveles estables más rápido.
Metabolismo Hepático	Despreciable para Cefalexina. Alto para Silimarina (Fase II).	Deficiencia sistémica en Glucuronidación.	La silimarina depende de la sulfatación alternativa en gatos, prolongando su permanencia tisular.
Excreción	> 80% Renal (Filtración y secreción tubular activa).	Renal (Cefalexina); Biliar/Fecal (Silimarina).	En gatos con disfunción renal, el aclaramiento disminuye drásticamente; riesgo severo de toxicidad.

CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS TÉCNICAS Hipersensibilidad Cruzada: Existe un riesgo teórico de reactividad cruzada (5-10%) en pacientes con antecedentes de anafilaxia a las penicilinas debido al anillo (\beta)-lactámico común. Interacciones: El uso concomitante con furosemida o aminoglucósidos puede potenciar el riesgo de nefrotoxicidad. El probenecid inhibe la secreción tubular, prolongando la vida media de la cefalexina.

Consideración en Felinos: Aunque se utiliza en medicina felina, la dosificación debe ser rigurosamente supervisada debido a la menor capacidad de glucuronidación de la especie, donde la silimarina actúa como un soporte crítico.Toxicidad y Reacciones Adversas La combinación presenta un alto índice terapéutico, pero no está exenta de efectos biológicos adversos derivados principalmente de la fracción antibiótica. Trastornos Gastrointestinales Directos: El efecto adverso más común en perros y, con un impacto marcadamente mayor y frecuente en gatos, incluye vómitos, diarreas leves y anorexia transitoria. Esto se debe a la alteración de la microbiota intestinal o la estimulación refleja del centro del vómito. Hipersensibilidad Inmunomediada: Reacciones de Tipo I (anafilaxia) o Tipo IV (dermatitis por fármacos). Existe un riesgo de reactividad cruzada (aproximadamente del 5 al 10%) en pacientes alérgicos a las penicilinas debido a la similitud del anillo betalactámico. Toxicidad Renal y Hematológica: En dosis extremadamente elevadas o tratamientos prolongados, se han reportado casos aislados de nefritis tubulointersticial, así como anemias hemolíticas inmunomediadas o leucopenias inducidas por cefalosporinas.

La silimarina carece de reportes de toxicidad sistémica significativa a estas dosis, mostrando una excelente tolerancia hepática y sistémica

Fisiopatología de la Toxicidad e Idiosincrasia Felina A nivel molecular, el gato (Felis catus) presenta una vulnerabilidad metabólica única respecto a esta formulación: Saturación de la vía de Sulfatación: La silimarina se depura principalmente mediante conjugación. Al carecer los gatos de una vía eficiente de glucuronidación (debido a la baja actividad de la enzima UDP-glucuronosiltransferasa UGT1A6), el compuesto satura la vía alternativa de sulfatación si se sobrepasan las dosis metabólicas. Esto puede generar una sobrecarga de metabolitos intermedios en tratamientos crónicos. Efecto emético neuroquímico en felinos: Los gatos poseen una alta densidad de receptores dopaminérgicos y adrenérgicos en la zona gatillo quimiorreceptora (ZGQ). Las cefalosporinas estimulan estos receptores de forma periférica (irritación local vagal gástrica) y central, provocando ptialismo (salivación excesiva), náuseas intensas y emesis con mayor frecuencia que en el perro.

Citopenia Inmunomediada: Los tratamientos que superan los 30 días con cefalexina pueden inducir el depósito de inmunocomplejos en las membranas de los eritrocitos y plaquetas, desencadenando anemia hemolítica inmunomediada (AHIM) o trombocitopenia por lisis mediada por complemento.

Precauciones, Contraindicaciones e Interacciones Insuficiencia Renal Crónica (IRC): La cefalexina se excreta principalmente por filtración glomerular de forma inalterada. En animales con disfunción renal grave, la dosis debe ser ajustada a la baja o se deben prolongar los intervalos posológicos (ej. cada 24 horas en lugar de cada 12 horas) para evitar la acumulación plasmática.

Contraindicación de Especie: Absolutamente contraindicado en pequeños mamíferos herbívoros o cecótrofos (conejos, cobayas, hámsteres, jerbos) debido a que destruye la microbiota Gram-positiva del ciego, desencadenando una enterotoxemia mortal.

Interacciones Farmacológicas: Evitar la administración concomitante con antibióticos bacteriostáticos (tetraciclinas, macrólidos) ya que antagonizan el mecanismo de acción bactericida de la cefalexina. Potenciación del riesgo de nefrotoxicidad si se asocia con diuréticos de asa (furosemida) o aminoglucósidos Condiciones de Almacenamiento y Conservación Para garantizar la estabilidad molecular de ambos principios activos. Temperatura: Conservar en su empaque original a temperatura ambiente controlada, idealmente entre 15 °C y 30 °C. Evitar la exposición a picos de calor extremo. Humedad y Luz: El monohidrato de cefalexina es sensible a la degradación por humedad ambiental excesiva y fotólisis. Los comprimidos higroscópicos o fraccionados deben mantenerse estrictamente dentro de su blíster de aluminio original hasta el momento exacto de la administración

VENTA: Bajo receta médica

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

REG. SENASA: F.082.031.N.01116
Fabricado en Perú por:
ALIFARSE E.I.R.L.
RUC 20603358881
Director Técnico:
M.V. E. Angelo Barrios Falcón
Reg. CMVP 3599
Telf. + 51 918 654 554

